Autos: 0800064-84.2022.8.12.0037
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Líbio Kelm
Réu: Município de Itaporã e outro

LÍBIO KELM ajuizou obrigação de fazer c/c requerimento de tutela de urgência em face do **MUNICÍPIO DE ITAPORÃ** e **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, ambos qualificados, ao argumento de que o autor é portador de ineficiência cardíaca (CID I 50) e fibrilação cardíaca (CID I 48), fazendo-se necessário, com a máxima urgência, da utilização do medicamento XARELTO (RIVAROXABANA) 20mg/dia. Aduz que o medicamento é de alto custo, não dispondo o demandante de condições financeiras para a sua aquisição. Requereu a concessão da tutela de urgência, bem como a procedência do pleito. Com a inicial juntou os documentos de fl. 10-26.

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), adveio parecer desfavorável ao pedido às fl. 31-42.

Por meio da decisão de fls. 43/48 foi deferido o pedido de liminar.

O Município de Itaporã (fls. 61/70) alegou, preliminarmente, a incompetência deste juízo, uma vez que o valor da causa se encontra dentro dos parâmetros de incidência da Lei n. 12.153/2009 que disciplina o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos entes federados. No mérito, arguiu que a jurisprudência atual entende que o tratamento fornecido pelo SUS deve ser privilegiado, em detrimento de opções diversas escolhidas pelo paciente, sempre que não for comprovada a sua ineficácia. Sustentou que o medicamento pleiteado na inicial está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Subsidiariamente, postula o ente municipal que, no caso de condenação, os honorários sucumbenciais sejam arbitrados de forma equitativa e que no caso de execução forçada, não haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas. Acostou documentos.

O Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 76/94) arguiu, preliminarmente, a competência da união para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, aplicando-se tese firmada pelo STF. No mérito, alegou a aplicação da tese firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (tema 106), sendo sua questão controvertida assim delimitada: “obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde". Além da recomendação da CONITEC para não incorporação dos medicamentos rivaroxabana, bem como face à ausência de comprovação da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público, o pedido deve ser julgado improcedente.

Impugnação à contestação às fls. 99/107.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

Instadas as partes a especificarem provas (fl. 117, pleitearam o julgamento antecipado da lide (fls. 118 e 120).

É o relatório. Decido.

Não havendo necessidade de produção de provas, profiro julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

I. Da Incompetência:

Em sua contestação, o ente municipal alega a incompetência do juízo, uma vez que o valor da causa não ultrapassa o patamar de sessenta salários mínimos.

Não prospera a tese de incompetência absoluta deste juízo, pois na comarca de Itaporã/MS o Juizado Especial funciona adjuntamente por meio de um único juiz, afastando, pois, a aplicação do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009 (*§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta*).

De mais a mais, vejamos o posicionamento do Egrégio TJMS em casos semelhantes:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER − COMPETÊNCIA − JUSTIÇA COMUM − AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. TUTELA PROVISÓRIA − FORNECIMENTO DE IMUNOTERAPIA − DEFERIDA − DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.* ***No caso em que a Comarca não possui instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para processamento e julgamento das demandas a ele inerentes será da vara com competência para as demandas dos juizados, que, no espécie, é a Vara Única da Comarca de Nova Alvorada do Sul.*** *A saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deverá garantir à sociedade a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com a tese fixada no REsp n. 1.657159, "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". Conforme tese fixada no Tema 793 no STF, não estando o medicamento pretendido padronizado no SUS, a União deverá compor o polo passivo da demanda e, por conseguinte, a competência para o julgamento da questão é da Justiça Federal. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411184-26.2021.8.12.0000, Nova Alvorada do Sul, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 16/11/2021, p: 18/11/2021).

REEXAME NECESSÁRIO E ApelaçÕES DO estado de mato grosso do sul E DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES − AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER − PRELIMINAR − VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS-MÍNIMOS − JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA − NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECÍFICO NA COMARCA − FORO DE BANDEIRANTES − AUSÊNCIA DE JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA − COMPETÊNCIA RELATIVA − MÉRITO − DIREITO À SAÚDE − RETOCOLITE ULCERATIVA − DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO − LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (RENAME) − RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES DE SAÚDE − ESCOLHA PELA AUTORA DOS ENTES DEMANDADOS − MANUTENÇÃO − DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS PRESCRITOS − RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ − RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS − TESE JURÍDICA ESTABELECIDA − REQUISITOS PREENCHIDOS − PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL − ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA − CABIMENTO − RAZOABILIDADE − APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1. Discute-se, nos presentes recursos: em preliminar, a) a competência da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos em Comarca na qual ainda não foi instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública; no mérito, b) a legitimidade da União para o fornecimento de medicamento não padronizado na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e, por isso, não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de modo a atrair, assim, para o caso dos autos, a competência da Justiça Federal; c) a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, a justificar intervenção judicial para obrigar o Poder Público à sua dispensação; e d) a possibilidade de fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública. 2. ***A rigor, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas com valor inferior a sessenta (60) salários-mínimos (art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

12.153, de 22/12/2009). 3. Todavia, nos termos do § 4º, do art. 2º, da Lei Federal nº 12.153, de 22/12/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), apenas no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública a competência será absoluta, de forma que, a contrario sensu, onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência do é relativa, podendo o autor optar pela Justiça Comum. *4. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Precedentes do STJ. 5. Nesse sentido, a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), relaciona-se ao Cumprimento De Sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não podendo importar na conclusão no sentido de eventual competência exclusiva da União, ou de outro ente público, pois isso implicaria afastar o caráter solidário da obrigação, que foi ratificado no precedente qualificado da Suprema Corte. Precedentes do STJ. 6. O STJ, no julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva, concluiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, c) existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento, observados os usos autorizados pela agência (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).. 7. Embora o réu-apelante reafirme a possibilidade de tratamento por meio das drogas oferecidas pelo SUS, não se pode esquecer que é o médico que prescreveu os remédios e que acompanha a paciente, sendo o profissional que melhor tem condições para avaliar sua necessidade. Deste modo, em que pese referida prescrição não gozar de presunção absoluta, mostra-se suficiente para demonstrar a necessidade dos fármacos indicados, cabendo ao requerido provar que tal indicação contém erros de diagnóstico ou de tratamento, de maneira que, não apontados tais fatos impeditivos, torna-se evidente a procedência do pedido. 8. Em casos como esse, não se pode negar vigência à norma constitucional que garante o direito à*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

saúde, mediante políticas sociais e econômicas, visando à redução do risco de doenças ou de outros agravos, sob o argumento de que há política pública específica ao tratamento da patologia de que é portadora a parte interessada nos autos. 9. É cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, para a hipótese de eventual descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou de tratamento de saúde. Precedentes do STJ. 10. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária. EMENTA − Apelação cível da defensoria pública − AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER − DIREITO À SAÚDE (ARTIGO 196, CF/88) − HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL − IMPOSSIBILIDADE − SÚMULA 421/STJ − PREQUESTIONAMENTO − RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se, no presente recurso, se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado de Mato Grosso do Sul à Defensoria Pública Estadual. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Súmula 421/STJ). Reafirmação do entendimento em precedentes recentes do STJ. 3. Havendo integral apreciação, pelo julgador, das matérias debatidas, torna-se desnecessária a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais utilizados pelas partes no embasamento de suas pretensões. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJMS. Apelação Cível n. 0800418-19.2020.8.12.0025, Bandeirantes, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 29/10/2021, p: 05/11/2021).

Posto isso, rejeito a preliminar invocada.

<u>II. Da necessidade de inclusão da União no polo passivo:</u>

Também, ressalto que não assiste razão ao Estado réu quanto à alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação e a pretensão de direcionamento da obrigação ao Município de Itaporã, aplicando-se a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793).

Ocorre que a legitimidade passiva dos réus decorre da própria Constituição Federal, que em seu art. 196 estabelece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O termo “Estado” mencionado no dispositivo constitucional é sinônimo de Poder Público, o qual, independentemente da esfera governamental, tem dever constitucional de proteger a vida e a saúde daqueles que necessitam de seu auxílio, e assim, por óbvio, o próprio Estado. O Estado é gênero, de que são espécies a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, daí a responsabilidade constitucional solidária e de cada um deles pela saúde e pelo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

fornecimento de medicação.

Nos termos do precedente vinculante do STF (Tema 793), os entes federados "são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde", o que autoriza à parte autora optar contra quem deseja demandar. Outrossim, o fracionamento da solidariedade sistêmica não afasta a legitimidade dos entes públicos demandados.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MEDICAMENTO. CÂNCER. PARECER FAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT). RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178. SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. Não se observa que o entendimento da Suprema Corte altere a ocorrência da solidariedade passiva, nem se traduza em litisconsórcio necessário a redundar na imprescindibilidade da inclusão da União no polo passivo da demanda. A solidariedade, por sua própria qualidade intrínseca, reflete na existência do litisconsórcio facultativo, pois ocorre quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda (art. 264/CC). Neste sentido, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça "segundo o qual, a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário, mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo. " (AgRg no Resp 1164933/RJ). O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. Aliás, é de competência comum, por força do que prescreve o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que União, Estado, Municípios e o Distrito Federal cuidem da saúde e assistência pública. Não procede o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, haja vista ser solidária a responsabilidade entre os entes federados, no âmbito e garantia à saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer um deles. Tendo em vista a competência solidária, não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

à União, nem da obrigação desta em ressarcir o Município e o Estado pelos gastos. Se o medicamento foi prescrito por profissional habilitado, se o Núcleo de Apoio Técnico. NAT é favorável e considerando a gravidade da doença que acomete o doente, deve o Ente Público fornece-lo. Sopesando o seu interesse econômico e o direito à vida e à saúde, deve-se privilegiar este último. (TJMS; AC 0800834-11.2020.8.12.0017; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 28/06/2021; Pág. 84)

APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. MEDICAMENTO INCORPORADO PARA DISPENSAÇÃO PELO SUS. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO FEITO. DESCABIMENTO1. Como consignado no Tema 793, e expressamente disposto no voto condutor do julgamento dos Emb. Decl. No RE 855.178-SE, o STF continua a reconhecer que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. E, ainda que as normas de regência (Lei nº 8.080/90 e alterações, Decreto nº 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 2. Medicamento incorporado para dispensação pelo SUS. 3. Preliminar rejeitada(...) (TJMG; APCV 0002191-77.2018.8.13.0348; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 18/11/2021; DJEMG 18/11/2021)

A toda evidência não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, porquanto eventual procedência da ação em nada afetará a esfera jurídica dos outros entes federativos, não se coadunando, evidentemente, à hipótese do art. 114 do CPC.

Por óbvio, a responsabilidade solidária confere ao credor a faculdade de escolher contra qual ou quais devedores litigará, a fim de buscar a satisfação da obrigação, podendo escolher um ou alguns co-obrigados solidários, ou mesmo todos, como lhe convier.

Nesse passo, entendo que a pretensão veiculada contra os demandados se legitima na medida em que se está exigindo deles o cumprimento de uma obrigação imposta pela Constituição.

Assim sendo, rejeito a preliminar alegada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

Com efeito, presentes os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, passo à análise do mérito.

É certo que o acesso à saúde foi elevado à condição de direito fundamental do homem, sendo incontroverso o dever do Poder Público, assim entendidos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, em disponibilizar serviços de saúde pública a todos os cidadãos. A responsabilidade é solidária.

A Constituição Federal, em seus art. 196 e 198, assim dispõe:

Art. 196. A saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I − descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II − atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III − participação da comunidade. § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Do mesmo teor a Lei Federal 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde):

Art. 2.º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4.º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

A matéria, portanto, recebe tratamento de direito inalienável da pessoa humana, pois a Constituição Federal consignou a obrigação de Estado propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, consagrando o Sistema Único de Saúde − SUS como responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e organizado de acordo com a descentralização, prestando serviço de atendimento de forma integral, ou seja, a assistência à saúde deverá

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

seguir as diretrizes estabelecidas constitucionalmente, de forma ampla e universal, sem restrições por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou dificultar o acesso a essa garantia constitucional.

Aliás, saliento que a questão referente à concessão de medicamentos pelo poder público restou decidida em sede de recurso repetitivo, por meio do Resp 1.657.156/RJ, cuja ementa transcrevo abaixo:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

No caso em tela, cito o relatório médico de fls. 19/19, destacando o que segue:

8) O(s) medicamento(s) é(são) imprescindível(is) para o tratamento do paciente, justifique:
R: Sim (...).

9) A disponibilização do medicamento é urgente:
R: Sim.

10) A não utilização imediata do(s) medicamento(s) poderá ocasionar quais das seguintes consequências?
R: ***Risco de morte e perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas.***

Em análise dos autos, concluo que os requisitos fixados pelo STJ encontram-se presentes, uma vez que demonstrada a hipossuficiência financeira da parte autora, eis que assistida pela Defensoria Pública, assim como foi comprovada a imprescindibilidade do medicamento, ante a gravidade das doenças que a acometem (ineficiência cardíaca e fibrilação cardíaca), sendo que o uso da medicação é de forma contínua.

Além do mais, há prova da ineficácia do tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), haja vista que o medicamento solicitado impede o agravamento do quadro de saúde da autora, não havendo substituto que não comprometa seu bem estar e vida.

Por óbvio, a alegação do NAT de que a RIVAROXABANA não está padronizada na RENAME, embora pertinente, não serve de impeditivo para o fornecimento do medicamento, desde que seja registrado na ANVISA, que é o caso, além de que os documentos acostados em cotejo com o receituário médico, notadamente pelo **risco de morte e perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas** (fl. 21), deixam evidente a imprescindibilidade do uso do fármaco.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE XARELTO (RIVAROXABANA 20MG). VÍTIMA DE AVC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

*HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. NECESSIDADE COMPROVADA. RESP Nº. 1.657.156-RJ. MEDICAMENTOS OFF-LABEL. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONFUSÃO RECONHECIDA. RECURSOS DO ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA 1. Diante da ausência de interposição de recurso voluntário pelo Município de Camapuã, deve ser conhecida de ofício a remessa necessária. 2. Não procede o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, haja vista ser solidária a responsabilidade entre os entes federados, no âmbito do direito e garantia à saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer um deles, cabendo à autoridade judiciária promover o direcionamento do cumprimento que "não se trata de formação do polo passivo da demanda, mas de posterior ressarcimento. 3. Caso dos autos em que restou comprovado por meio de laudo médico circunstanciado que a paciente sofreu Acidente Vascular Cerebral Isquêmico em 2009 e em junho de 2019, apresentando disfagia após o último episódio e, ainda, padece de Hipertensão Arterial Sistêmica, não existindo tratamentos oferecidos pelo SUS com a mesma eficácia do indicado, bem como que não foi obtido sucesso com o uso de outros fármacos. 4. Restando evidenciada a necessidade do medicamento prescrito e a imprescindibilidade de seu uso, não podendo a paciente arcar com os custos para sua aquisição, impõe-se ao Poder Público o dever de fornecê-lo gratuitamente, independentemente de estar ou não inserido em lista fornecida pelo Ministério da Saúde, dado que o direito à vida é incondicional. 5. Possível o fornecimento de medicamentos "off label", ou seja, fora da indicação contida na bula, quando indicados pelo profissional de saúde que atende diretamente o paciente, que é quem melhor possui condições de conhecer acerca da necessidade do tratamento. 6. As astreintes têm caráter sancionatório-coercitivo, não são indenizatórias e sua finalidade é intimidar e constranger o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de um dever de abstenção, que deve ser imediatamente cumprida pelo sujeito passivo da relação processual. 7. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula nº 421). * (TJMS; AC 0800214-32.2020.8.12.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 01/06/2021; Pág. 51)*

RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "XARELTO 20MG (RIVAROXABANA). ERRÔNEA APLICAÇÃO DA TESE 106 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ACOLHIMENTO DO PLEITO INICIAL E NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA. CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA. 1. É cabível reclamação contra decisões de Turma Recursais Estaduais de Juizados Especiais para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial repetitivo e em enunciados das Súmulas daquela Corte Superior. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 2. É a hipótese dos autos, em que o tema 106 dos recursos repetitivos foi aplicado de maneira errônea pelo Juízo, na medida em que a situação dos autos que demonstra a imprescindibilidade o fornecimento do medicamento pleiteado, e ser a parte hipossuficiente economicamente, devem os entes públicos fornecê-lo. (TJMS; Rcl 1401148-22.2021.8.12.0000; Rel. Juiz Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 10/05/2021; Pág. 132)

APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E REMESSA NECESSÁRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO XARELTO (RIVAROXABANA) PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO REJEITADA MÉRITO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA 106) REQUISITOS PREENCHIDOS SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. Compreende-se como Estado todos os três entes da Federação União, Estado e Município sendo, inclusive, solidária a responsabilidade entre eles, de modo que qualquer um poderá ser acionado judicialmente a fim de garantir assistência médico-hospitalar mais adequada e eficaz, no sentido de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, não havendo falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo. É obrigação do Estado assegurar a todos o direito à saúde, materializado pelas medidas e políticas tendentes a satisfazer, igualitariamente, esse direito, que tem previsão na própria Constituição Federal (art. 196), desse modo, comprovado que a paciente está sendo tratada pelo SUS e havendo prova da imprescindibilidade do medicamento pretendido na inicial, a sentença deve ser mantida. Restou demonstrada a obrigação de Poder Público em fornecer os referidos medicamentos, ainda que estes não estejam incorporados no Sistema Único de Saúde (SUS), estão devidamente registrados na ANVISA, a parte é assistida pela Defensoria Pública, razão pela qual pressupõe

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

sua hipossuficiência, o que demonstra estarem devidamente preenchidos os requisitos necessários e cumulativos dispostos no RESp n. 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). (TJMS; APL-RN 0802949-52.2019.8.12.0045; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida; DJMS 28/09/2020; Pág. 55)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública. Fornecimento de medicamentos. Rivaroxabana. Sentença de procedência da ação. Documentos apresentados que comprovam os requisitos necessários a obtenção da benesse. Responsabilidade solidária dos entes da Federação. Súmula nº 37, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inaplicabilidade do Tema 793. Preenchimentos dos requisitos necessários a obtenção do fármaco pleiteado (Tema 106). Fornecimento de medicamentos decorre do direito à saúde, conforme determina o artigo 196, da Constituição da República. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000676-49.2021.8.26.0048; Ac. 14775589; Atibaia; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Shintate; Julg. 30/06/2021; DJESP 12/07/2021; Pág. 3084)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE PADECE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (CID. 10 I10), DIABETES MELLITUS (CID. 10 E11) E TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (CID. 10 I26.9), RAZÃO PELA QUAL NECESSITA DO MEDICAMENTO XARELTO 20 MG (RIVAROXABANA), E NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM SEU CUSTO. 1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente. 2. Medicamento deferido, mas sem qualquer observância à marca comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais conveniente, sendo que a receita médica deve ser atualizada a cada três meses. 3. Remessa necessária. Não acolhida, com observação. (TJSP; RN 1001752-88.2020.8.26.0066; Ac. 13959893; Barretos; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Julg. 14/09/2020; DJESP 22/09/2020; Pág. 2313)

Outrossim, destaco que o médico não está adstrito às listas do SUS, especificamente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), podendo prescrever terapias/medicamentos ali não relacionados, sendo o ente público obrigado a adquiri-los e repassá-los aos beneficiados, em atenção ao artigo 196 da Constituição Federal.

Por fim, considerando que o relatório médico não fez ressalva

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

acerca da impossibilidade de substituição por genéricos ou similares, fica permitido o fornecimento de genéricos.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo **procedente** o pedido inicial, para o fim de condenar o réu ao fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20mg, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a 15 (quinze) dias, com sequestro dos valores da conta bancária vinculada à propaganda institucional.

Declaro resolvido o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando-se a liminar.

Atento ao princípio da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, dispensadas em razão do art. 2º, da Lei nº 9.289/1966, bem como condeno o Município de Itaporã ao pagamento das custas processuais e dos honorários à DPE no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

No que pertine aos honorários advocatícios em relação ao ESTADO, sendo a demanda proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, que é um órgão do próprio Estado, não se afigura factível condená-lo a pagar verbas de sucumbência em favor de seu próprio órgão.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

> *RECURSO OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS. A Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. Aplicação do art. 381 do Código Civil, no sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, visto que a Fazenda Pública não poderá ser reconhecida como obrigada para consigo mesma. Recursos parcialmente conhecidos e providos. (TJMS, 1ª Turma Cível, rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, julgado em 10.11.2009)*

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421: *Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença*.

Dispenso remessa necessária.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.

Deverá ser observado pela serventia deste juízo: (a) para a hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º); (b) havendo apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §2º); (c) sendo suscitada(s) preliminar(es) nas contrarrazões, intime(m)-se o(s) recorrente(s) para, em 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se (CPC, art. 1.009, §1º).

Atendidas as formalidades acima para a hipótese de interposição de recurso deste *decisum*, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, com as homenagens de estilo, independentemente de nova conclusão.

Decorrido o prazo do recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o reexame necessário, considerando que a medicação é de uso contínuo, o que implica em prazo indeterminado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e, após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedidas às necessárias anotações.

Itaporã, 29 de abril de 2022.

Evandro Endo
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 04/05/2022 às 16:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800064-84.2022.8.12.0037 e código tRDHRnOx.